El proceso grupal

Del psicoanálisis a la psicología social ‹1›

Enrique Pichon-Rivière

Nueva Visión

Escaneado con CamScanner

EMPLEO DEL TOFRANIL EN PSICOTERAPIA INDIVIDUAL Y GRUPAL *

Mi contribución a este Coloquio Internacional sobre Estados Depresivos trata del *uso instrumental y situacional* de una droga antidepresiva (Tofranil), empleada durante el transcurso de tratamientos psicoterápicos individuales y grupales. El objetivo principal del uso de la droga es facilitar la *movilización* de estructuras o pautas estereotipadas (estereotipos) que se presentan y operan con las características de *resistencias* al progreso del proceso terapéutico. Las ansiedades frente al cambio o aprendizaje, de tipo depresivo y paranoide, promueven la estructuración del estereotipo ("más vale pájaro en mano que cien volando"). La *oportunidad* de un coloquio sobre estados depresivos se fundamenta en el hecho de que por fin la psiquiatría aparece progresivamente centrándose alrededor de la génesis, estructura y vicisitudes de una *situación depresiva básica.* Creo necesario esclarecer previamente en términos generales el texto y contexto del marco o esquema de referencia con el cual pienso y opero. Haré entonces, primero, una rápida crónica del desarrollo biográfico de dicho esquema referencial.

I

Construcción de un esquema conceptual, referencial y operativo (ECRO)

Mis investigaciones sobre una *situación depresiva básica* (1938) partieron de dos campos o marcos de trabajo en continua interac-

* *Acta Neuropsiquiátrica Argentina*, 6, 1960.

Escaneado con CamScanner

ción: 1) de una práctica continua como psicoterapeuta de casos individuales y de grupos, y 2) de una larga experiencia paralela a la anterior y combinada a menudo con ella, empleando tratamientos biológicos: shock hipoglucémico, convulsoterapia, sueño prolongado, etcétera. En el año 1946 publiqué la primera síntesis personal sobre una teoría general de las neurosis y psicosis introduciendo los conceptos de *pluralidad fenoménica*, de *unidad funcional y genética* (enfermedad única) y de *policausalidad*.

Sostenía entonces: "A través del psicoanálisis de esquizofrénicos y epilépticos y apoyado por las observaciones realizadas durante los tratamientos biológicos se nos hizo evidente *un núcleo psicótico central*, bien delimitado, y del cual parten todas las otras estructuras como maneras o tentativas de resolver dicha situación básica. Esta situación está configurada con los elementos que caracterizan el estado depresivo, con sus conflictos y mecanismos específicos". "... que la situación así establecida ... situación básica de las psicosis y configurada en el sentido de una estructura melancólica, es el punto de donde se inicia la elaboración de otras situaciones que van a configurar todos los otros tipos clínicos descriptos. En términos generales podríamos decir que ésta *es la única enfermedad*: todas *las demás estructuras son tentativas que hace el yo para 'deshacerse de esa situación depresora básica ...'*. Creada esta situación penosa el yo tiende a librarse de ella apelando a un nuevo mecanismo de defensa que es la *proyección*. Si es proyectada en el cuerpo se configura la *segunda estructura, que es la hipocondríaca*. Todo lo que el hipocondríaco dice de sus órganos es una transposición de la situación anterior, pudiendo decirse que, mientras el *melancólico es un sujeto perseguido por su conciencia, el hipocondríaco lo es por sus órganos* ... Si la proyección se hace en el exterior se configura *la tercera estructura: la estructura paranoide* ... A la fórmula ya expresada de que el melancólico es un sujeto perseguido por su conciencia y el hipocondríaco por sus órganos, agregaremos que el paranoide lo es por sus enemigos interiores proyectados" (3, 4, 5).

Indagaciones posteriores en continuidad con éstas me permitieron la construcción de un esquema conceptual, referencial y operativo cuyas características podemos definir así a grandes rasgos:

1) La *respuesta depresiva* debe ser considerada como pauta total de conducta frente a situaciones de frustración, pérdida, pri-

vación, teniendo además un carácter unitario en su aparición, estructura y función.

2) Una *situación depresiva* infantil está incluida en el desarrollo normal (M. Klein, [2]), junto con otras situaciones, *esquizoide* y *epileptoide*.

3) La *situación depresiva básica* opera en el desarrollo de toda enfermedad mental (situación *patogenética vivencial*). El factor disposición puede ser expresado en términos de *grados de fracaso en la elaboración de la situación depresiva infantil* (duelo). La regresión, durante el proceso de la enfermedad, reactiva la posición depresiva infantil (situación patogenética), así como promueve el empleo de la posición *esquizoide* (situación patoplástica e instrumental), tanto como la situación *epileptoide* (situación patorrítmica temporal).

4) Otra situación depresiva debe ser descripta, y es aquella que está incluida en todo proceso *terapéutico*. La resolución de las divisiones o escisiones del yo y de sus vínculos, es decir, el proceso de integración, sólo es posible a través de este nuevo pasaje por una situación depresiva (grado de *insight* conseguido; es la consecuencia junto con el proceso de re-disociación).

5) La estructura de la pauta de reacción incluye al *conflicto de ambivalencia* frente a un objeto total. De esto surge el sentimiento de culpabilidad y la inhibición o lentificación de determinadas funciones del yo. La tristeza, el dolor moral, el sentimiento de soledad y desamparo derivan de la pérdida de objeto y de la culpa. La posibilidad de *reparar* y *sublimar* están seriamente impedidas.

6) Frente a esta situación de sufrimiento surge la posibilidad de una regresión a una posición anterior, *operativa e instrumental*, para el control de la ansiedad (situación esquizoide). El mecanismo básico aquí es la división o *disociacion* (*split*) del yo y de sus vínculos, con la consiguiente emergencia de la ansiedad paranoide que reemplaza a la culpa. La situación epileptoide y patorrítmica señala las formas en que el tiempo se manifiesta a través del manejo de las *ansiedades básicas o miedos*.

7) *Las neurosis* son técnicas defensivas contra ansiedades básicas, psicóticas. Dichas técnicas son las más logradas y cercanas a lo normal y están alejadas de la situación depresiva básica prototípica. *Las psicosis* son también formas de manejo menos

Escaneado con CamScanner

exitosas que las anteriores, lo mismo que *las psicopatías*, donde priva el mecanismo de delegación. *Las perversiones* se manifiestan como formas complejas de elaboración de las ansiedades psicóticas y su mecanismo general se centra alrededor *del apaciguamiento del perseguidor. El crimen* constituye la tentativa de aniquilar la fuente de ansiedad máxima proyectada en el mundo externo; mientras que este proceso centrado en el propio sujeto configura la conducta *suicida*.

8) El *sufrimiento* inherente a la posición depresiva está vinculado al incremento del *insight* (autognosis), es decir, al conocimiento y comprensión de la realidad psíquica interna y externa. El fracaso de la elaboración de la posición depresiva (duelo), además de las consecuencias señaladas, acarrea inevitablemente el predominio de defensas que entrañan el bloqueo de las emociones y de la actividad de la fantasía. Impiden sobre todo la aparición de un cierto grado de autognosis necesario para una buena adaptación a la realidad. (Las defensas *maníacas* que emergen en ciertos casos condicionan la superficialidad manifestada por el yo, impidiendo de esta manera su fortalecimiento y profundización durante el proceso terapéutico.)

9) Sostiene Rickman (6) que *no existe una psiquiatría sin lágrimas* y que es mejor enfrentar concretamente lo relacionado con la vivencia depresiva sin, por supuesto, descuidar otros aspectos en relación con el proceso de progresión. Además, en el contexto de toda psiquiatría dinámica *la indagación y el proceso terapéutico son inseparables*. El paciente, dice Rickman, sólo podrá revelarnos los más profundos niveles de su sufrimiento a condición de experimentar, al mismo tiempo que acontece el proceso de indagación, un alivio de su propio sufrimiento debido al proceso mismo de esta indagación (tenemos aquí un modelo de lo que se denomina indagación activa operativa dentro del campo de la psicología).

10) Este esquema referencial fue completado después con el *encuadre grupal* de la situación depresiva, así como con las nociones de portavoz de la ansiedad del grupo (el paciente), pauta grupal estereotipada, depresión básica grupal, grupo operativo, coincidencia del proceso de comunicación, esclarecimiento, aprendizaje y capacitación centrada en la tarea y el proceso terapéutico. Una espiral dialéctica señala la dirección de este complejo proceso.

II

Psicoterapia individual y Tofranil (uso instrumental y situacional de la droga)

H. Azima (1950) ha estudiado en particular las modificaciones psicodinámicas provocadas por la administración de Tofranil, tratando de encontrar una explicación de los efectos de esta droga. Observó lo siguiente: 1) Un cambio en la dirección de las preocupaciones. Éstas pasan de los objetos internos a los externos. 2) Una disminución del sentimiento de culpabilidad. 3) Una orientación diferente de los impulsos agresivos y en ciertos casos su liberación bajo la forma de explosiones agresivas. 4) Una reorganización secundaria de las cargas de objeto. 5) Euforia y conducta hipomaníaca en pacientes clasificados como maníacos depresivos. 6) Necesidad de cierta intensidad de la depresión para la obtención de estos efectos; las ligeras manifestaciones depresivas no son influidas por el Tofranil. 7) Disminución de la necesidad de beber alcohol. 8) Un cambio centrado únicamente sobre el estado depresivo. 9) Ninguna modificación de las características básicas de la personalidad, anteriores al estado depresivo (1).

Apoyado en estas observaciones, Azima pone en evidencia una mutación del equilibrio de la agresividad en relación al superyó. Esta reorganización trae como consecuencia una sedación del estado depresivo, pero este cambio en el equilibrio psicodinámico parece ser transitorio y necesita, además, para producirse, una cierta intensidad de depresión.

El Tofranil representa hasta ahora el único timoléptico y, como consecuencia, nuevas orientaciones en psicofarmacología. Al mantener el humor y elevar el impulso vital, desarrolla una acción selectiva sobre el *núcleo central* de la depresión, sin los efectos de un sedante o de un estimulante o euforizante.

La indagación sobre la acción de esta droga antidepresiva (Tofranil) —que realicé con ayuda de mis colaboradores, los doctores F. Taragano, G. Vidal, A. Marranti y A. Benchetrit— tenía como marco de referencia la consideración de la situación depresiva básica ya descripta. También se incluyó el concepto de que la enfermedad lleva implícita como causa o consecuencia una perturbación del aprendizaje y de la comunicación.

Escaneado con CamScanner

El monto de ansiedad predominantemente *depresiva* sería responsable de la *pauta* estereotipada de conducta anormal. La *ansiedad ante el cambio*, hecho posible por la acción específica del esclarecimiento, provoca por otro lado la *resistencia al cambio*, que se denomina en términos generales reacción terapéutica negativa. El *Tofranil obra bajando el monto de agresión, de ansiedad, de ambivalencia y de culpa*. De esta manera su acción posibilita un cambio producido por el esclarecimiento del campo de trabajo. Se produce la apertura de un círculo vicioso anterior, *creándose las condiciones* para la emergencia de una espiral dinámica de aprendizaje y comunicación. La transferencia negativa disminuye (al disminuir la hostilidad) y la tarea entre paciente y psicoterapeuta se orienta hacia un nivel de mayor integración. *La vivencia de monotonía o estereotipia se hace consciente en su estructura y motivaciones*. Se observa un gran progreso en el *insight* y el paciente llega a vivenciar la entrada en una posición depresiva necesaria a todo tratamiento realmente eficaz. De distintas maneras expresa que *siente que cosas dispersas comienzan a juntarse, que cobran vida y ahora las entiende mejor* (integración).

Para ilustrar esta situación prototípica de todo tratamiento tomaré el caso analizado por uno de mis colaboradores, el Dr. Guillermo Vidal. Se trata de una enferma de 35 años, casada, que consulta por depresiones periódicas, invernales casi siempre, coincidentes con la estación del año en que su marido viaja más. Su primer episodio depresivo ocurrió como consecuencia del primer parto. De ordinario duraban de 3 a 4 meses. Se le hizo varias veces insulina y *electroshock*. Comienza su tratamiento psicoanalítico en *mayo de 1959*, en un estado de depresión leve. Tras unas cortas vacaciones, en julio, sobreviene la *sexta crisis depresiva*. La depresión se desarrolla lenta y progresivamente, acompañándose de una *gran inhibición* psicomotriz. La enferma se muestra *impermeable a las interpretaciones* que se le hacen. Es de notar el tono plañidero y *monótono* con que habla. Dice: "Yo me siento muy mal." "Yo no puedo ni levantarme de la cama." "Me resulta imposible trabajar." "Quiero ayudar a mis hijas, y no puedo." *"No puedo, no puedo"*, repite insistentemente. *Como el cuadro se agrava ostensiblemente* y la enferma apenas puede concurrir a la consulta, el terapeuta decide administrarle Tofranil en dosis progresivas hasta 5 grageas diarias. Esto fue

un viernes; al día siguiente, sábado, no se registraron mayores variantes. Pero el lunes, cuando ya había tomado 8 grageas, la enferma aparece cambiada. Dice: *"No sé lo que me pasa. Es como si no pudiera seguir estando triste. O es que ahora estoy triste, pero no angustiada.* Me siento simplemente cansada. No puedo precisar bien lo que me está pasando." Con cierta extrañeza asiste a su propio acontecer. Dos días después la transformación es bien manifiesta; lo expresa así: "Doctor, hoy me siento bien." "Fíjese que ayer de noche pude cohabitar con mi marido, y en forma natural (la enferma era frígida), cosa que nunca había ocurrido antes..." "Además me pasa una cosa extraña, y es que ahora *es como si comprendiese de golpe todo lo que Ud. me dijo antes, en el curso del análisis, y que las cosas dispersas se juntaran todas y cobrasen vida y yo las entendiera mejor.* No sé francamente lo que me pasa."

A la semana de *iniciado el tratamiento* con Tofranil la paciente se halla prácticamente recuperada, mejor aun que durante los intervalos anteriores, con la *vivencia* de que ha comprendido muchas cosas (*insight*) y de que ella es otra mujer. Diríase que, súbitamente, *hubiera cristalizado* el efecto de *cinco meses de tratamiento psicoanalítico*. La enferma tomó en total 100 grageas de Tofranil.

III

Psicoterapia grupal (grupo familiar). Uso instrumental y situacional del Tofranil

La locura es la expresión de nuestra incapacidad para soportar y elaborar un monto determinado de sufrimiento. Este nivel de tolerancia es específico para cada uno de nosotros y depende en gran medida de la dificultad relativa de superar la depresión infantil básica, tejida de frustraciones, aspiraciones, demandas biológicas excesivas, provocando la emergencia de la agresión (rabietas), ansiedades depresivas y paranoides (los miedos), la ambivalencia, la culpa, inhibiciones, etcétera.

La emergencia de una neurosis o psicosis en el ámbito de un grupo familiar significa que un miembro de este grupo asume un rol nuevo, se transforma en el *portavoz* o *depositario*

Escaneado con CamScanner

de la ansiedad del grupo. La estructura grupal se altera, suceden perturbaciones en el sistema de adjudicación y asunción de roles, aparecen mecanismos de segregación del enfermo, dependiendo en gran medida el pronóstico del caso de la intensidad de estos mecanismos de segregación. *El enfermo es alienado por su grupo inmediato.*

Una determinada *inseguridad social* se ha instalado en el seno del grupo. Esta inseguridad está ligada a ansiedades *frente al cambio.* Estas ansiedades son de dos tipos tal como consignamos con anterioridad: *ansiedad depresiva*, expresada como temor o miedo a la pérdida de un status determinado, y *ansiedad paranoide* frente a las nuevas condiciones de vida o miedo al ataque. La pauta estereotipada se configura después de la emergencia de la enfermedad en uno de sus miembros. Constituye un mecanismo de seguridad patológico; es un sistema en *círculo cerrado.* Y un sistema de realimentación entra al servicio de la pauta estereotipada.

El sistema de *interrelaciones del grupo familiar* sigue un modelo básico triangular: el sujeto, la madre y el padre, o sus sustitutos, a quienes se les adjudican determinados roles que ellos asumen. Los hermanos, según el sexo, se agruparán en el contexto del rol materno o paterno. Distorsiones en este sistema hacen surgir una serie de perturbaciones y *malentendidos.*

Es en este ámbito o campo donde la enfermedad de uno de los miembros del grupo debe ser comprendida y esclarecida. Este grupo *estereotipado* y poco productivo se transformará con el uso de determinadas técnicas en el *instrumento mismo* de la *operación correctora.* La técnica empleada es la que denominamos *grupos operativos de esclarecimiento,* de aprendizaje, de capacitación o tarea que actúa como proceso terapéutico. La tarea está centrada en la curación del enfermo. Una nueva red de comunicaciones se configura. Y esto posibilita el cambio y el aprendizaje consecuente. La ansiedad global asumida por el paciente *se fragmenta* de nuevo y cada miembro del grupo se hace cargo de una parte de ella. *El grupo se transforma en una empresa cuyo negocio es la curación de uno de sus miembros a través del esclarecimiento de todos.*

Pero de nuevo, como en el análisis individual, nos encontramos con que la pauta estereotipada básica asienta en la situa-

ción depresiva. Si la ansiedad incluida en dicha pauta es demasiado intensa, la resistencia al cambio (reacción terapéutica negativa) se estructura; el tratamiento se estanca, apareciendo serias dificultades en el manejo de la situación global. Es en este momento cuando incluimos de una manera instrumental y situacional una droga (Tofranil) que es administrada a todo el grupo a la vez con el objeto de disminuir *el estado de tensión grupal* proveniente de la situación depresiva, estereotipada.

Señalaré ahora los lineamientos generales de este método de psicoterapia grupal, tomando como unidad de trabajo el *grupo familiar* con la inclusión de una variable, una droga administrada a todo el grupo. El principio general —como ya lo señalé— es el que todo sujeto que enferma psíquicamente es porque ha asumido un rol particular, y en cierta medida operativo, dentro del grupo familiar, al transformarse en el *portavoz y depositario de la ansiedad* del grupo. De esta manera, al adjudicarle el grupo familiar ese rol y al asumirlo él, se consigue un efecto que puede expresarse como superación de la situación de caos subyacente. El grupo es transformado a través de la *tarea* psicoterápica en un verdadero grupo operativo donde, en base a esclarecimientos progresivos, hay un reajuste en los roles, una mayor *heterogeneidad* en sus miembros y una mayor *homogeneidad* en la tarea.

Las técnicas empleadas por el coordinador o terapeuta del grupo consisten en crear, mantener y fomentar la comunicación, que va adquiriendo un desarrollo progresivo en forma *de espiral.* De esta manera el grupo aprende, se comunica, opera y se alivia de la ansiedad básica.

El esclarecimiento familiar que sucede a veces en forma de "revelaciones" tiende a disminuir progresivamente *el malentendido básico* existente en el grupo. Los sistemas referenciales, las ideologías, comienzan a tener una importancia particular en este análisis grupal; la reducción del *índice de ambigüedad,* debido a la resolución de contradicciones intragrupales (*análisis dialéctico*), constituye una de las tareas principales del grupo. El *esquema de referencia* del grupo se realimenta ahora, se mantiene flexible, es decir, no estereotipado. La situación de rigidez o estereotipia de la conducta grupal enferma constituye el punto de ataque principal: allí se centra la tarea. El grado de estereotipia logrado por el grupo, después de la eclosión de una psicosis

Escaneado con CamScanner

en su seno, configura el monto de resistencia al esclarecimiento y a la curación.

Creada la situación de *estereotipo* funcionan también *los mecanismos de segregación*, de expulsión o alienación del paciente. Si esto se produce, el grupo cambia su forma y se estereotipa en el sentido de no admitir más al miembro segregado. El *pronóstico* de la enfermedad de éste está principalmente en relación con la receptividad o no receptividad del grupo. Éste suele organizarse para mantener fuera al paciente, realizando a veces verdaderos sacrificios con tal que se mantenga la segregación.

Los *procesos de motivación* (motivos y necesidades) y la *acción* en su fase de articulación tienen que ver con los *procesos de decisión* dentro del grupo. El temor ante el cambio y la inseguridad social están en la base de las ansiedades del grupo, que se expresan en términos de las ansiedades básicas depresiva y paranoide, como ya dijimos. La posición depresiva constituye esencialmente la situación patogenética y la modificación de la ansiedad del grupo va a girar alrededor de su resolución (de los miedos y rabietas del grupo).

La lucha contra las ansiedades depresivas y los *estereotipos configurados* como defensa van a constituir el centro de todo ataque terapéutico, ya sea por medio de la psicoterapia, ya por la acción de una droga antidepresiva. El propósito es transformar un círculo vicioso, cerrado, en un círculo beneficioso, con aperturas dialécticas sucesivas.

La administración de Tofranil a *todo el grupo familiar* al mismo tiempo tiene por finalidad disminuir y fraccionar la ansiedad, haciendo más posible la ruptura del estereotipo familiar y la transformación de este grupo rígido no operante en un grupo flexible, plástico, operativo, que toma ahora por tarea concreta la curación de la enfermedad del grupo en ocasión de la emergencia de ésta en uno de sus integrantes.

En suma: el coordinador o terapeuta del grupo favorece con su técnica los vínculos dentro del grupo. El campo de la tarea tiene por base una situación triangular, debiendo comprenderse e interpretarse el vínculo transferencial dentro de este contexto triangular. La familia se reorganiza en la tarea de luchar contra la ansiedad del grupo acaparada por su portavoz (el paciente). Los roles se redistribuyen y llegan a operar como

liderazgos funcionales. Los mecanismos de segregación que contribuyeron a alienar al paciente disminuyen. Las ansiedades son redistribuidas, el estereotipo pierde su rigidez y el grupo puede enfrentar entonces situaciones de cambio. La *droga favorece la ruptura del estereotipo* y, por la acción del esclarecimiento psicoterápico, el grupo se integra tomando ahora la característica de una estructura funcional.

Bibliografía

(1) Azima, H., "Psychodynamic alterations concomitant with Tofranil administration", *Canad. Psychiat. Ass. J.*, 1959, IV, S 172.

(2) Klein, M. y Rivière, J., *Las emociones básicas del hombre*, Nova, Buenos Aires, 1960.

(3) Pichon-Rivière, E., "Patogenia y dinamismos de la epilepsia", *Revista de Psicoanálisis*, 1944, II, 615.

(4) —"Contribución a la teoría psicoanalítica de la esquizofrenia", *Revista de Psicoanálisis*, 1946, IV, 1.

(5) —"Psicoanálisis de la esquizofrenia", *Revista de Psicoanálisis*, 1947, V, 293.

(6) Rickman, J., *Selected Contributions to Psychoanalysis*, The Hogarth Press, Londres, 1957.

Escaneado con CamScanner